林口婦產科工作規範

- 基本工作規範/ 產科/ 婦科/ 婦癌科/ 臨床照顧病人常用 order / 婦女泌尿科 / 不孕科 / 自費特材 -

<基本工作規範>

1. 一般事項：
   - 照護病人若有問題可先請教同次專科之住院醫師、Fellow、NSP，並與主治醫師討論
   - Clerk2 醫師專責照護病人床數上限為 6 床，如超過上限請通知 NSP 或主治醫師給予適當的安排。
   - PGY 學員專責照護病人床數上限為 14 床，如超過上限請通知 NSP 或主治醫師給予適當的安排，平日接 10 床/假日接 15 床
   - 病房 procedure cover 順位: 當科 R ➔ 當科 senior R➔ Fellow
   - 若遇病房緊急情況，如急救及病人病情嚴重變化，由當科 R 處理， 由該次專科 R cover，並連絡主治醫師。
   - 病歷要準時完成，跟主治醫師查房，下班前完成電子交接班！
   - 接 New patient: 4:30 PM 前由當科接病人 (以病人報到時間為準)
   - 門診：主治醫師門診及教學門診(請準時)。
   - 開手術病人 order 前務必看住院通知單備註欄/門診病歷/手術排程的註記
   - 各手術**自費耗材**請務必**根據術式開立**對應項目(有範本)。
   - **Cytotec (Misoprostol)** 請務必點選**自費**使用。
   - **要開婦科手術但月經超過一個月沒來的未停經女性請務必驗孕**。
   - 開化療病人 order 前務必看住院通知單備註欄/門診病歷的註記
   - 開急診病人 order 前務必看會診病歷中急診婦產科的回覆
2. 刀房：
   - 自己主治醫師的刀、自己跟。
   - 刀房 on call 順序排定會因每名醫師臨床狀況給予盡量公平排定原則。如跟刀超過下班時間，亦請通知刀房人員安排值班醫師支援。
3. 值班事項：
   - 完成電子交接班 (打完 progress note 如果無特別交班事項會自動帶入)
   - 因每日值班情況不同，總醫師有權力調動值班區域及工作內容
   - 值班接 New Patient 請完成<1>Admission Order <2>Admission Note. **<3>Pre-OP Note**. <4>開刀患者自費特材同意書。 (檢查手術同意書是否有簽名或過期、開立自費特材同意書，若有疑問告知當科或值班 R 或 CR)

<產科>

<剖腹產術前常規> 醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → A02-C/S → admission order

1. 術前用藥:

   Enema 1pc CM （現在大部分都不用灌腸，參見下表）

   Oxytocin(Piton-s) 2pc IVF to OR 或自費 Carbetocin 1pc IV to OR 擇一（參見下表）

   Cefazolin 2g IVD to OR (對 Cefalosporin 過敏替代藥物: Clindamycin 300mg 3pc IVF to OR)

2. IVF: LR 1000ml run 125ml/hr since CM, 若高血壓/雙胞胎改成 run 80ml/hr

3. **前置胎盤/**其他**術前 Hb<8** 請備血 LPR2u

   植入性胎盤請備血 LPR2u, FFP 2u, Platelet 12u, Whole blood 2u

   備血同時記得開輸血同意書（開立備血 order 時即會自動跳轉同意書頁面）

4. 自費特材同意書：（依病人意願開立）

- 自費防沾黏：(本院材編)

  Protahere 6ml (84-286-000006) $12500
  Seprafilm 5”x6” (84-286-430506) $12700
  Barrigel 40mg/mL, 10Ml (84-286-076204) $ 15000

- 自費術後防水傷口敷料：(注意:只能開一片)

  美皮蕾防水型術後彈性矽膠敷料 10X20cm (84-996-495400) $550 元

	Enema CM	**Carbetocin 1pc IV (to OR)**	**防沾黏**	**美皮蕾 只能開 1 片!**
產科主治				
張舜智	X	V	Protahere	V
趙安祥	X	X	Seprafilm	X
闕河晏	X	X	Protahere	X
詹耀龍	X	Previa/Twin	Seprafilm Protahere (都可以, 但以 Seprafilm 為主)	V
彭秀慧	X	V	Protahere	V
李彥璋	X	V	Protahere	X 術後再使用
許晉婕	X	V	Protahere	X
江啟源	X	Previa/Twin	Barrigel 10ml	V
生殖內分泌主治				
黃泓淵	V	V	Protahere	X
張嘉琳	X	V	Protahere (不主動問病人)	X

	Enema CM	Carbetocin 1pc IV (to OR)	防沾黏	美皮蕾 只能開 1 片!
吳憲銘	X	V	Protahere	V
黃尚玉	X	V	Protahere	V
陳亮萱	X	V	Protahere	V
徐樂天	X	V	Protahere	V
宋衍儒	X	V	Protahere	V

[術後敷料&凝膠] 問各樓是只要文字 order 還是需要自費特材同意書 (各 station 不同) 本院編號

美皮蕾防水矽膠敷料 $550/片 84-996-495400

兆泓水凝膠傷口敷料 $690/片 84-152-037170

Mepiform 美皮豐美容疤痕矽膠布 $1605/片 84-094-604300

Wellderm 矽膠疤痕貼片 $720(4pc/組) 84-094-WDS002

倍舒痕疤痕凝膠 15g $1980/條 68-007-015012

芙立康疤痕凝膠 20ml $2080/條 68-007-015020

玻麗舒疤痕凝膠 15g $1850/條 68-007-005541

優潔疤痕護理凝膠 20g $2800/條 68-007-009302

< CS 排氣後 order renew > **醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → A02-C/S → daily order**

= On the service of Dr.OOO

= 病人嚴重度分級: D 級(有使用氧氣者 C 級)

= Vital signs as ward routine

= Sip water then on diet as tolerable

= PP care QD & prn

= Breast care bid

= Change dressing, medium (10-20cm): post CS DAY 1&3, PRN (有些病人沒有用美皮蕾要刪除)

= Remove Foley (after removing epidural catheter or 4 hrs after removing PCA or 未用術後止痛手術 24 小時後移除)

= Intermittent catheterization(ICP) prn

= IVF with D0.225 1000ml run 60ml/hr (for PCA or for anti)

(若病人沒發燒、沒用 PCA、沒有肚子脹也可以 **DC IV + on IV lock for antibiotics**

= DM/GDM 有在用 insulin 的 case: Check Finger Sugar AC + 3PC (2hrs)

藥囑：

1. 抗生素：續手術後的抗生素並減掉已使用的天數
   - 常見: Cefazolin + Gentamicin * 2 天, Ceftriaxone + Metronidazole * 7 天
   - 如果抗生素已經打完術後開的天數，看術後抽血 WBC 決定要不要給口服 Cefuroxime or Cefadroxil
   - 闕河晏: WBC > 15000 開 Cefazolin + Gentamicin, WBC>10000 開 Cefadroxil 1pc Q12H PO
2. 止痛藥：Acetaminophen (李彥璋) or Mefenamic(Postan) 1pc QID or Diclofenac 1pc TID(許晉婕)
3. 若需要止痛針：健保 Nubain 1pc IM Q4H PRN if pain score>4
   自費 Dynastat 1pc IV Q12H PRN if pain score>4
4. 胃藥：MgO 1pc QID PO
5. Hb < 9，請開鐵劑口服，ferrous gluconate QD~BID PO,
6. 軟便劑: Sennoside A+B 1pc HS PO
7. 血壓藥: 原本的血壓藥持續開立
8. 口服血糖藥: 原本的口服血糖藥持續開立
9. 胰島素：長效的胰島素基本上減半, 短效的胰島素減半後依之後的血糖調整
10. 胰島素針頭：材編 84-021-320566

<Preeclampsia or Eclampsia 產後還有使用 MgSO4 病人>

醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → A10-MgSO4 → Daily order

- IVAC: MgSO4 maintain 1-2gm/hr (run 10-20ml/hr) for 24 hrs (照術後的 order 開)
- Check DTR, I/O, RR Q4H(If decreased DTR, , U/O<100cc/4 hrs, or RR<12/min, please notify doctor)
- Prepare Calcium gluconate 1pc, Diazepam(Valium) 1pc at bedside
- If run 2gm/hr, 請開抽血檢驗 check Mg Q6H (Seizure prophylaxis therapeutic level: 4-8 mg/Dl)
- 藥囑：MgSO4 1PC IRRE IVF *1 天 首日量 1 瓶 每日量 0 瓶
  Ca gluconate 10ml 1PC once IV (prepare at bedside), Diazepam 2ml 1PC once IV (prn for seizure)

<其他產科病房常見藥物/檢查>

自費九價子宮頸疫苗 Gardasil 9 IM $6000

自費百日咳疫苗 Tdap IM $1700

自費退奶針 Cabergoline 1pc PO once $125

高層次超音波 S49-125 (單胞胎, 自費), S49-125D(雙胞胎,自費)

產科超音波 S49-109(單胞胎,健保), S49-109D(雙胞胎,自費)

子宮頸長度測量 S50-055 自費

<產科出院常規>

分類	**自然生產 NSD/Vacuum**	**剖腹生產 C/S**	**安胎病人**
出院日	生產日+3 (多住算自費)	1.生產開刀日+4 2.住院日=開刀日時，多數主治醫師可以 + 5	由主治醫師決定，安胎藥物改成口服劑型才能出院。
回診日	**不用回診**：張嘉琳 **一週**：江啟源(四度裂傷) **兩週**：詹耀龍闕河晏(四度裂傷)/黃尚玉/許晉婕 **四週**：謝武橋/梁景忠 **六週**：闕河晏(W3 下午)/趙安祥/彭秀慧/吳憲銘/李彥璋/江啟源/徐樂天 **八週**：張舜智(W4 下午)/詹耀龍 *不確定就約 6 週後	通通一週回診 闕河晏(W3 下午) 張舜智(W4 下午)	3~7 天回診 張舜智(W4 下午)
出院帶藥原則	止痛藥&胃藥 ***3 天** 病人要軟便藥的話請開 Sennoside **四度裂傷**要多帶藥 3 天 1. 優碘坐浴 Povidone-iodine 15ml BID (自費！) 2. 軟便 Sennoside 1PC HS	止痛藥&胃藥 ***3 天** 病人要軟便藥的話請開 Sennoside 住院才調整的 HTN 或 CM 藥物請開足夠到回診時間的量 (至少七天！) 約一週後 CV 或 Meta 回診	MA order 或比照住院用藥 **只開 3 天**，約 3 天後回診 (除非 MA 有另外指定時間) 自費： Nifedipine 10mg Indomethacin 25mg **(32 週後禁用, 絕對勿開超過 3 天!!!)** 健保：Ritodrine 10mg
乙診診斷	生產週數併自然生產/真空吸引協助陰道生產	生產週數併剖腹產適應症(手術紀錄上有寫)併剖腹生產	安胎週數併早期破水/早產陣痛/產前出血/子宮頸閉鎖不全
乙診醫囑	住院日期/自然生產 or 真空吸引協助陰道生產日期/出院日期/出院後續門診追蹤	住院日期/剖腹生產日期/出院日期/出院後續門診追蹤	住院日期/子宮頸環紮手術日期/出院日期/出院後宜休養/出院後續門診追蹤

* 乙診通常 NP 姐姐會先暫存好，可以先取出暫存看看，如果沒有再自己照範本打
* 記得出院照護計畫書 (若有更改出院帶藥就要印新的)
* Dr.許晉婕若要約 CV 桃園回診，約 Dr.林莞芹

<安胎七天到期 Order renew> 可以參考病人七天前的 Order, 自行增減下列範本內容

醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → A14-Tocolysis at Ward → Daily order

= On the service of Dr.OOO
= Vital signs as ward routine
= On fetal monitor and check FHB BID & prn [小週數者 on toco and check FHB by doppler BID & prn] 擇一
= Diet as tolerated
= Bed rest (或可以下床如廁,參考之前的 order)
= PP care QD & prn
= Intermittent catheterization (ICP) prn [有 Foley 者開 Foley care QD & prn]
= IVF with D5S0.225 1000ml keep open [詹耀龍醫師 NS 1000ml keep open, 並開 NS 1000ml 藥囑 Irre IVF]
= IVAC: D5W 500ml + Ritodrine 3pc run 10~20ml/hr
= IVAC: Atosiban line run 8~12ml/hr
= 病人嚴重度分級: D 級(有氧氣 C 級), 有氧氣者記得開呼吸治療 Simple mask 6L PRN(要加註) 並刪掉 pulse oximeter
= 三天換針抽血(不確定可以不開 , 闕河晏有用 Ritodrine 的一律抽 CBC/DC/CRP/D-dimer/BNP)

藥囑：基本上都續用之前的藥

口服安胎藥：自費 Nifedipine 10mg, 自費 Indomethacin 25mg, 健保 Ritodrine 10mg PO

點滴安胎藥：自費 Atosiban (開 2 隻 once, 健保只給付第一次療程, 所以在病房通常是自費, 記得印自費單), 健保 Ritodrine 3pc IRRE IVF 首日 3 每日 3

抗生素：Ampicillin, Cefazolin, Ceftriaxone+Metronidazole

黃體素：健保 Progesterone(micronized) 100mg PO

<產科子宮頸環紮> 醫藥囑本科範本 → 4720 產科範本 → A15-Mc Suture at Ward → Admission order

= Admit to the service of Dr. OOO
= Vital signs as ward routine
= On full diet
= Check fetal heart beat by doppler Q8H & prn
= Pre-op order:
= Op will be perform on (日期)
= Op method: (同手術同意書)
= Op site: (同手術同意書)
= Sign consent form: (同手術同意書)
= NPO since midnight (except drug 看有沒有開藥給她吃)
= Sent patient to OR on call
= Skin preparation at OR
= On Foley at OR
= IVF: D0.225S 1000ml run 60ml/hr since cm (有 run Ritodrine 的改 keep open)
= IVAC: 闕河晏 D5W 500ml + Ritodrine 3PC run 10ml since cm

藥囑：

= Cefazolin 2gm IVD once to OR
= 自費口服 Indomethacin 25mg PO once：李彥璋送刀前吃 2 顆, 詹耀龍/趙安祥送刀前吃 1 顆
= 點滴 Ritodrine 10mg 3pc once IVF：闕河晏 D5W 500ml + Ritodrine 3PC run 10ml since cm (<16 週自費)

<婦科>

*** 腹腔鏡手術 Laparoscopy**

醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → B01-Laparoscopy → Admission order

Pre-op order:

= Op will be performed on (日期)

= OP method (同手術同意書一字不差, 記得加最上面的標題**(婦產科腹腔鏡)**

= Op site (同手術同意書一字不差)

= Sign consent form (同手術同意書一字不差, 記得加最上面的標題**(婦產科腹腔鏡)**

= Sign 自費特材同意書 (腹腔鏡一定要) [開立方法看後面,如果不知道要簽什麼至少簽最基本的]

= 術中決定防沾粘 (看病人意願)

= Sent patient to OR on call

= On Foley at OR

= Skin preparation at OR

= NPO since midnight (有血壓藥或術前藥記得 except drug)

= IVF: D0.225S or NS run 60/80/100/125ml/hr since cm (看病人年齡體重&是否有高血壓糖尿病微調)

D0.225S 1000ml + RI 6u run 80ml/hr since cm (若病人嚴重的糖尿病)

= 備血: Hb 9 備 (周宏學全部手術都要備, 顏志峰<10.5 備, 蘇育瑩 LM/LAVH <10 備, 湯雲心要問過 MA)

= 輸血: Hb 8 輸 LPR2u, Hb 6 輸 LPR4u (王錦榮 Hb 6 輸, 顏志峰<9.5 輸 LPR, 蘇育瑩 LM/LAVH <9 輸)

* 有動到子宮的手術如 LM, LAVH 比較需要輸備血, 只有動到卵巢的手術可以考慮不用

Pre-op 藥物 **(腹腔鏡通則) 可以參考附錄 routine 表**

- Antibiotics ：全部都要！

一般婦科手術	Cefazolin 1g/vial, 1PC IV to OR; >80kg→2 PC IVD to OR
癌症分期手術(OP time>4hr)	Cefazolin 1g/vial, 2PC IV to OR; >80kg→4 PC IVD to OR

  - Allergy to cephalosporin: clindamycin 300mg 1pc IVD and gentamycin 80mg 1pc IVD Bring to OR)
- Fleet Enema 1pc CM 大部分內視鏡科的醫師不用，其他次專科大多需要 看表開立
- 止吐針 Kytril 1pc IV to OR **自費 /**止痛藥 Dynastat 1pc IV before to OR **自費**都要帶除非病人拒絕
- **Myomectomy**：
  - **Oxytocin 4pc IVF to OR** (吳凱筠, 黃怡婷, 蘇育瑩, 顏志峰, 黃泓淵 2pc IVF to OR) 基本上都要帶
  - **Tranexamic acid 4pc IVF to OR** (顏志峰,王錦榮, 吳凱筠, 黃怡婷, 蘇育瑩不用 Tranexamic acid) 基本上都要帶
  - **自費** Terlipressin 1mg/vial 1pc IV to OR 大部分不帶; 看表開立
- **LAVH/LH/LSH**：
  - 健保 Phenzaopyridine(Pyridium) 1pc PO IRRE HS + CM 首日量 2pc 每日量 0pc; 看表
  - **自費** Vitamin B complex 1pc IVF to OR (只有黃慧君, 謝武橋要開)
- **TCR 子宮鏡**: 子宮頸軟化 Misoprostol(Cytotec) 1pc PO IRRE HS + CM 首日量 2pc 每日量 0pc

  *** * * 自費 並 開立 Misoprostol 知情同意書** (張嘉琳不用開, 謝武橋 by MA order) 大部分都; 看表
- **Tubal plasty**: 自費 Patent blue V 50mg/12ml/amp 1pc IV to OR
- 婦癌分期手術或有寫 **Sentinel 淋巴結**: 自費 ICG 1pc IV to OR (李奇龍, 張廷璋, 黃寬仁, 黃慧君, 陳威君…)

*** * * 記得 LMYO 要帶 Piton-s & Transamin（請看前面通則）* * ***

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Bupivacaine 0.5% 20ml**	**Dexamethasone 5mg/1mL**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	1pc Loc to OR **(自費)**	4pc IV to OR （健保）
李奇龍	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V	V	V(CM)		V	V
	LOVA	V	V				V	V
	TCR		V			V		V
	癌症分期不需 Terlipressin, 3D 腹腔鏡需簽自費切結書 3 萬元;LAVH/LSH Nystatin vag 1pc HS							
顏志峰	LMYO		V			V CM		V
	LAVH		V		V 送刀前吃 1 顆	V CM		V
	LOVA		V					V
	TCR		V(看病人)			V		
	住院通知單無 CI/UA 可不另抽, **Hb 10.5 備 9.5 輸,** 3D 腹腔鏡需簽自費切結書 3 萬元 通常會自己在門診開好自費特材單							
王錦榮	LMYO		V					
	LAVH		V					
	LOVA		V					
	TCR					V if 沒生過		
	住院通知單無 PT/APTT/UA 可不另抽; **LOVA 要補單 抽 AMH (自費 800 元)**; **若病人不用 Dynastat 則開 Acetaminophen 2pc CM PO**; **Hb 9 備 6 輸**							
吳凱筠	LMYO		V	V				
	LAVH		V		V			
	LOVA		V					
	TCR		V(看病人)			V if 沒生過		
	通常會自己在門診開好自費特材單; **Hb <9 備&輸**							

*** * * 記得 LMYO 要帶 Piton-s & Transamin（請看前面通則）* * ***

	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Bupivacaine 0.5% 20ml**	**Dexamethasone 5mg/1mL**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	1pc Loc to OR **(自費)**	4pc IV to OR （健保）
黃怡婷	LMYO		V	X				
	LAVH		V		V 1pc CM			
	LOVA		V					
	TCR					V		
	通常會自己在門診開自費特材單, Fleet enema 看住院單							
蘇育瑩	LMYO		V	X				
	LAVH		V		V			
	LOVA		V					
	TCR					X		
	通常會自己在門診開自費特材單，防沾黏術中決定，LM/LAVH Hb 10 備 9 輸							
翁瑄	LMYO		V	V				
	LAVH		V		V 1pc 送刀前			
	LOVA		V					
	TCR					V if 沒生過		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，刪防粘粘的部分，防沾黏術中決定							
麥迪森	LMYO		V	V				
	LAVH		V		V 1pc 就好 送刀前吃			
	LOVA		V					
	TCR							
	Hb <9 備&輸							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
張廷彰	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		X			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 或 開腹都用 Harmonic, Scope 都要簽 Endobag(大), 防沾粘選 Tisseel spray 噴管							
黃寬仁	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		2pc HS			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料 Scope: Ligasure Maryland; 開腹癌症刀: Ligasure Exact, 防沾粘 prefer Adept *看門診病歷上面會註明							
周宏學	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Cancer 刀不管 Scope 或 開腹 都要開 Harmonic ; LM or LAVH 要開 Ligasure; LM 要開 V-loc Scope 一律開 XS wound retractor & 大 Endobag [依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本, 再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料], 防沾粘 prefer Protahere 6ml							
林政道	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
黃慧君	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		X, 帶 VIt. B **（自費）**			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	會在門診病歷/手術排程上註明 ICG for sentinel LN or Ligasure or 防沾黏							
趙安琪	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	會在門診病歷/手術排程上註明 ICG for sentinel LN 或 其他特材							
陳敏煜	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	術前可能使用長效 Naldebain 止痛針, 防沾粘 prefer Arista 3gm, Protahere 10ml, MateRegan (看排程)							
湯雲心	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V					
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	比較喜歡 Ligasure Maryland, 防沾粘 prefer Hyalobarrier, Seprafilm or Tisseel [通常會自己在門診開好特材]							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
陳威君	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料 LM or LAVH 要開 Ligasure, Scope cancer 刀帶 Harmonic LM 要帶 V-LOC, 防沾粘 prefer Arista, Materegan, barrigel, adept (看手術排程上會註明)							
董秀容	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面防沾粘的材料 比較喜歡用 Ligasure, 防沾粘選 Tisseel spray 噴管							
張淑涵	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Cancer 刀不管 Scope 或 開腹 都要開 Harmonic ; LM or LAVH 要開 Ligasure; LM 要開 V-loc Scope 一律開 XS wound retractor & 大 Endobag [依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本, 再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料], 防沾粘 prefer Protahere 6ml							
張宸邠	LMYO		V				V	V
	LAVH		V					
	LOVA		V					
	TCR					V		
	看手術排程簽自費特材							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
宋永魁	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本 比較喜歡用 Ligasure							
黃泓淵	LMYO	V	V				V (2PC)	V (2PC)
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面 防沾粘的材料 Scope 可簽 Ligasure; LM 防沾粘 prefer Interceed tuboplasty 可用 Patent blue 如果有沾黏可能的話要 colon preparation with Bowklean 2pc, 看門診/排程							
張嘉琳	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V					
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料 Scope 不用 Ligasure/Harmonic!!! 防沾粘 Prefer Protahere 6ml tuboplasty 可用 Patent blue *(進開刀房後再決定要不要用所以就帶進去)							
吳憲銘	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V					
	LOVA	V	V					
	TCR							
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料 Scope 不用 Ligasure/Harmonic!!! tuboplasty 可用 Patent blue *(進開刀房後再決定要不要用所以就帶進去) 防沾粘: Scope 用 Arista 3g, TCR 用 MateRegan 宮安康							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
黃尚玉	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改裡面 Ligasure & 防沾粘的材料							
陳亮萱	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，刪防粘粘的部分，防沾粘術中決定							
徐樂天	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，刪防粘粘的部分 防沾粘 prefer Protahere							
宋衍儒	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，刪防粘粘的部分，防沾粘術中決定							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
梁景忠	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本 Scope 可用 Ligasure, LM 可簽 V-LOC							
林益豪	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改防沾粘的材料 Scope 可用 Ligasure, 手術排程上會註明特材 (Sling, 防沾粘, PRP, New Epi 等…)							
謝武橋	LMYO	V	V				V	V
	LAVH	V	V		X, 帶 Vit. B (自費)			
	LOVA	V	V					
	TCR					V 看排程怎麼吃		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本，再改防沾粘的材料; Dexan 2pc once SC to OR Scope 可用 Ligasure, LM 可簽 V-LOC, 手術排程上會註明特材(Sling, 防沾粘, PRP…)							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
張舜智	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本 Scope 可用 Ligasure, LM 可簽 V-LOC							
闕河晏	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本 Scope 可用 Ligasure, LM 可簽 V-LOC							
彭秀慧	LMYO	V	V	V			V	V
	LAVH	V	V		V			
	LOVA	V	V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本 Scope 可用 Ligasure, LM 可簽 V-LOC							
李彥璋	LMYO		V	V				
	LAVH		V		V			
	LOVA		V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本							

MA	手術方式	**Fleet Enema**	**Dynastat Kytril**	**Terlipressin**	**Pyridium** (Phenazo pyridine)	**Cytotec (Misoprostol)**	**Piton-s** (Oxytocin)	**Tranexamic acid**
		1pc CM	1PC IV **（自費）**	1pc IV to OR **（自費）**	1pc IRRE PO HS & CM （健保）	1pc IRRE PO HS & CM **（自費）**	4pc IVF to OR (健保)	4pc IVF to OR （健保）
江啟源	LMYO		V	V			V	V
	LAVH		V		V			
	LOVA		V					
	TCR							
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本							
許晉婕	LMYO		V				V	V
	LAVH		V		V			
	LOVA		V					
	TCR					V		
	Scope 依術式選婦女內視鏡科顏醫師範本, 刪防沾粘的材料 防沾粘 prefer Tisseel + 塗管							

*** 一般婦科開腹手術 Laparotomy**

醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → B02-Laparotomy (not-cancer) → Admission order

Pre-op order:

= Op will be performed on (日期)

= OP method (同手術同意書一字不差, 記得加最上面的標題**(婦科開腹)**

= Op site (同手術同意書一字不差)

= Sign consent form (同手術同意書一字不差, 記得加最上面的標題**(婦科開腹)**

= Sign 自費特材同意書 (若有防沾粘 or Harmonic or Ligasure)

= 術中決定防沾粘 (看病人意願)

= Sent patient to OR on call

= On Foley at OR

= Skin preparation at OR

= NPO since midnight (有血壓藥或術前藥記得 except drug)

= IVF: D0.225S or NS run 60/80/100/125ml/hr since cm (看病人年齡體重&是否有高血壓糖尿病微調)

D0.225S 1000ml + RI 6u run 80ml/hr since cm (若病人嚴重的糖尿病)

= 備血: Hb 9 備 (周宏學全部手術都要備, 湯雲心要問過 MA)

= 輸血: Hb 8 輸 LPR2u, Hb 6 輸 LPR4u

Pre-op 藥物(通則)：

- Fleet enema 1pc cm 全都要！(就算有 Bowklean 也還是要有 enema!!)
- 懷疑嚴重沾粘可能會要 **Colon preparation**：
  - 3rd Pre-OP day: Low residual diet
  - 2nd Pre-OP day: Liquid diet
  - 1st Pre-OP day: Clear liquid diet
  - 自費 Bowklean 2pc once(1pc at 12:00, 1pc at 18:00 on 1st Pre-OP day (中午及晚上)
  - 腎功能差(CCR<30)、癱瘓患者改 Niflec (PEG 4000) 1PC (建議 16:00 用)
- 止痛藥 Dynastat 1pc IV before to OR 自費 基本上都要除非病人拒絕
- **<u>Myomectomy</u>**:
  - Oxytocin 4pc IVF to OR 基本上都要帶
  - Tranexamic acid 4pc IVF to OR 基本上都要帶
- Antibiotics 全都要! (Cefalosporin 過敏: Clindamycin 600-900mg IVF to OR)

一般婦科手術	Cefazolin 1g/vial, 1PC IV to OR >80kg→2 PC IVD to OR
癌症手術(op time may>4hr) Debulking or staging	Cefazolin 1g/vial, 2PC IVD to OR >80kg→4 PC IVD to OR

<其他婦科病房常見藥物/檢查>

自費柳普林 Leuplin Depot 3.75mg (一個月一支) / 12.5mg(三個月一支)

< 一般婦科開腹手術 or 婦癌手術排氣後 order renew >

醫藥囑本科或他科範本 → 4720 產科範本 → B02-Laparotomy (not-cancer) or B03-Laparotomic oncology surgery → Daily order

= On the service of Dr.OOO

= 病人嚴重度分級: D 級(有使用氧氣者 C 級)

= Vital signs as ward routine

= Sip water then on diet as tolerable (如果術中有傷到腸子的話要繼續 NPO)

= PP care QD & prn

= Change dressing, medium (10-20cm) or large(>20cm): QD & prn

= Remove Foley (by MA order)

= IVF with D0.225 1000ml or D5S/D5W run 80-100ml/hr (如果讓病人開始吃東西就稍微調降點滴速度)

= Record I/O Q8H? Record Urine amount Q8H? (看病人前幾天尿量, 年紀, underlying disease 決定)

= Remove NG tube? (如果引流量<100 且不會噁心嘔吐可以考慮拔掉)

= Record V/B 引流量 Q8H (如果有放引流管)

= Finger sugar? (如果病人有 DM)

藥囑：

1. 抗生素：續手術後的抗生素
   - 常見: Cefazolin + Gentamicin, Ceftriaxone + Metronidazole
2. 止痛藥：Acetaminophen or Mefenamic(Postan) 1pc QID
3. 若需要止痛針：健保 Nubain 1pc IM Q4H PRN if pain score>4
   自費 Dynastat 1pc IV Q12H PRN if pain score>4
4. 止吐針 Novamin 1pc IM Q4H PRN if nausea or vomiting (prn 不一定要開)
4. 胃藥：MgO 1pc QID PO
   點滴：PPI 可健保 3 天預防術後壓力性潰瘍, 如果開始 on diet 就 DC
   (開 PPI 要記得開 N/S 100ml (藥囑) for PPI)
   也可以考慮 H2 blocker 如 Famotidine, Cimetidine
5. Hb < 9，考慮開鐵劑口服，ferrous gluconate QD~BID PO
6. 血壓藥: 原本的血壓藥持續開立
7. 口服血糖藥: 原本的口服血糖藥開回去
8. 胰島素：吃得好之後把 insulin 加回去，劑量可能要先減少

<婦癌科>

*** 癌症手術**

<手術一般常規> 大部分同前面婦科開腹手術

- 備血: WB 2U, LPR 2U, FFP2U, PLT 12u
  - 黃寬仁/張廷彰/湯雲心/董秀容醫師的病人不常規備血
  - 周宏學醫師除 CONE、TCR、D&C 外均需備 LPR 2U
- Colon Preparation 大部分都要，怕術中會切腸子，除非真的很早期的癌症
  - Fleet enema 1pc CM 全都要！ (就算有 Bowklean 還是要開 Fleet enema)
  - 3rd Pre-OP day: Low residual diet
  - 2nd Pre-OP day: Liquid diet
  - 1st Pre-OP day: Clear liquid diet
  - 自費 Bowklean 2pc once (1pc at 12:00, 1pc at 18:00 on 1st pre-op day(中午及晚上)
  - 腎功能差(CCR<30)、癲癇患者改 Niflec (PEG 4000) 1PC (建議 16:00 用)
- 止痛藥 Dynastat 1pc IV before to OR 自費 基本上都要除非病人拒絕

  (PS: 周宏學醫師不做神經阻斷，打長效 Nalbuphine)
- Antibiotic to OR (double doses): 全都要！
  - ✓ BW<80kg: Cefazolin 1g/vial：2PC IV to OR
  - ✓ BW>80kg: Cefazolin 1g/vial：4PC IVD to OR

2.Chemotherapy：(第一次化療開同意書: 同意書→ 血液腫瘤科 → 化學治療)

- 可進行 chemotherapy 條件：Hb>10, ANC>1500, PLT>100k
- 上化療藥前須處理：

Hb	<9.5~10	→輸血 LPR (張廷璋醫師的病人不一定要輸,可參考上次 baseline)
ANC (absolute neutrophil count) [WBC x (Band+Neutr%)]	<1500	→打 GCSF (自費 or 健保)打完 48hrs 後 check data 治療過程中曾經 WBC<1000 or ANC<500 即可使用健保 GCSF(查病歷)。劑量可參考之前 • Lenograstim 250mcg(大隻) • Rhg-csf 75mcg(小隻) or 300mcg(大隻) * 如果缺藥就換另一種, 張廷璋醫師比較喜歡小隻的劑量
Platelet	<5 萬	→不隨便輸 PLT <3 萬，評估有無出血狀況，需要時才輸 Plt 12u 可會診中醫吳宜鴻醫師 若病人可負擔的話可考慮 • Eltombopag 25mg QD PO 自費 $1186 • Romiplostim 250mcg QW SC 自費 $13793

- 住院打 Chemotherapy 的病人：
  - ✓ Port-A flush: Heparin 100u/ml, 10ml/vial, 1pc once (小心不要開到小朋友的！)
  - ✓ 打 Taxol(Paclitaxel): 開立 Dexamethasone 5mg/ml/amp, 4pc IRRE IVF(4pc on D1(要打出日期) 00:00 & 4PC on D1(要打出日期) 06:00 使用) , 首日量領 8, 每日量領 0, 天數 1 天

** **B 肝 survey:**

a. 第一次化療:1. HBSAG(EIA), 2. ANTI-HBS AB(EIA), 3. ANTI-HBC AB, 4. ANTI-HCV AB

b. HBV carrier survey 大全套: HBSAG(EIA), ANTI-HBS AB(EIA),ANTI-HBC AB,HBE AG, ANTI-HBE AB, ROCHE HIGH PURE(測 B 肝病毒量的), bilirubin D,bilirubin T, Albumin, PT, aPTT, gamma GT, abdominal echo

****有打 Pembro 的病人額外需 Q3M 追蹤**: P, Mg, HbA1C, Cortisol, free T4, T3, ACTH, GH, PRL, anti-TPO ab, 請開出院 order, 或入院 order 時確認有沒有漏掉 (範本→ 婦癌 → AAA)

3. Chemotherapy-induced neutropenia**

- Definitions: **ANC <1500** cells/microL ; Severe neutropenia **ANC <500** cells/microL
- High risk of serious complications:
  1. ANC < 500 cells/microL
  2. 合併有:意識改變、低血壓、腹瀉、肺浸潤、管路感染、肝腎功能變差(liver function >5times; ClCr< 30 ml/min)
  3. Prophylatic antibiotic treatment: Target *Pseudomonas aeruginosa & GNB* 常用藥物: fluoroquinolones (Ciprofloxacin and Levofloxacin)
- **Neutropenic fever**
  - ✓ Fever survey: CBC-DC,BUN,Cr,NA,K,Cl,CRP,U/A,U/C,Blood culture, Port-A culture, CXR..
  - ✓ Initial single antipseudomonal beta-lactam agent:
    - Cefepime – 2 g IV Q8H
    - Meropenem – 1 g IV Q8H
    - Imipenem-cilastatin – 500 mg IV Q6H
    - Ceftazidime – 2 g IV Q8H
    - Piperacillin-tazobactam – 4.5 g IV Q6H - Q8H

4. Granulocyte colony-stimulating factors (G-CSFs)使用

a. Primary prophylaxis:
--During the 1st cycle of myelosuppressive chemotherapy
--Goal: preventing neutropenic complications throughout all of the chemotherapy cycles.
--使用時機: risk of neutropenic fever is between 10-20 %

b. Secondary prophylaxis:
---In subsequent chemotherapy cycles after prior neutropenic fever
--Goal: maintaining chemotherapy dose intensity while avoiding dose reduction.
--Dose reduction or delay as the primary therapeutic option rather than routine administration of CSFs

c. Therapeutic use in neutropenic fever
--In High-risk features :

ANC <100cells/uL >10days	Age >65	Uncontrolled primary disease
Septic Shock	Pneumonia	Persisted Fever
Invasive fungal infection		

5. 婦癌科化療病人出院注意事項：

a. 今辦明結

b. 7~10 天後回診, 回診抽血 CBC, WBC/DC, (D-dimer) at OPD 印出 A5 檢驗單

c. 出院帶藥單

d.出院照護計畫書 (改出院帶藥後要重印, 上面要是最新的藥)

e.下次住院通知單,通常是 3 週後再進來打化療(也有可能 4 週)

住院通知單記得開檢驗：CBC, WBC/DC, BUN/Cr, Na/K/Cl, ALT, U/A, tumor marker(看之前抽過什麼)

f. 診斷證明書 prn 看病人

<臨床照顧病人常用 order>

檢查

- 胃鏡 Panendoscopy (M23-002): 需 NPO 8 小時，婦癌術前或上消化道出血可安排。
- 大腸鏡 colonoscopy (S43-051A): 會診大腸外科，依回覆開立醫囑，並請在同意書上加【合併瘜肉切除】，須 colon prepare，PEG 1PC + Dulcolax stat then fleet enema 2PC CM
- 胃鏡 + 大腸鏡一起的話：（M23-002）+（M23-013）+（減痛：M23-122T）
- 超音波:婦科腹超(S49-101)、陰超(S49-104)、腹部 GI(M23-034) 、腎臟(M24-021)、心臟(M22-060)
- 子宮鏡 (S49-030): 疑似內膜癌需病理切片確認。
- 婦科膀胱鏡(S44-023M): 於婦科檢查中。
- PET scan: Whole body tumor scan 健保 (N73-085A，名字短的那項，給付標準為 advanced cervical cancer, recurrent cervical cancer, melanoma) 自費 (N73-085 不符合者為自費)
- Bone scan (N73-060): 懷疑骨轉移。
- CT/MRI: 請至放射診斷科之 C-T 或 MRI 選項中點選，需注射顯影劑者需 NPO 4 小時，須同意書。檢查部位依適應症點，例如疑似 brain meta 或 ICH 等點 brain，胸部為篩檢遠端轉移，腹部或骨盆多為術前或復發之評估。**先開一個部位例如 pelvis or abdomen, 再註明要從哪照到哪**
- CTA of pulmonary embolism: 懷疑肺栓塞，從 C-T 選項中點。
- 胸腔超音波合併胸水抽吸 (M21-053): 胸腔科檢查，找 pleural effusion 原因。
- 超音波導引引流: 放射診斷科檢查下按 Sonography -> Echo-guided drainage
- PICC: 放射診斷科檢查下按 Angiography -> PICC，預計只需短期化療使用。
- CT-guided biopsy: 放射診斷科檢查下按 C-T，選部位。
- 四肢(Duplex color scan vein M22-074): 懷疑 DVT

會診

- 婦科中醫(一定要選前面有婦科的): 產後
- 麻醉科: 高風險麻醉，有嚴重或不明心肺疾病，高齡病患，或需做無痛大腸鏡
- Procto: 安排大腸鏡、晚期卵巢癌減積手術術前會診(已預期 table consult)、腸道手術術後併發症、腸道減壓手術。
- GS: 卵巢癌減積手術術前會診(已預期 table consult)、腸道手術術後併發症、腸道減壓手術

- URO: 卵巢癌減積手術術前會診(已預期 table consult)、術後泌尿道損傷、排膀胱鏡或 stent 置換
- 中醫: 血小板低下，會診吳宜鴻醫師，週二、四會來診視病人，記得跟會診中醫住院醫師確認出院帶藥藥量。其他可能適應症: 腸胃、手麻、疲倦。
- CVS: 裝 port-A。
- RT: 子宮頸癌 CCRT、術後輔助 RT、癌症局部復發、症狀緩解-->寫原因或影像檢查報告
- 營養照會 M37-003 ($ 300) [營養師那邊會自動計價，但仍需 sign 自費同意書]

其他提醒:

- 開立檢查後，請務必與該檢查室聯絡確認檢查時間。大部分普通單用點排程的，如果急著要做就開急單打電話給檢查室
- 侵入性檢查，例如 CT-guided biopsy、各式抽吸、放管路，注意有無一週內凝血功能(PT/aPTT, Plt: > 100000)，請與檢查執行醫師聯絡確定凝血功能標準(主治醫師指定檢查執行醫師、檢查室聯絡得知)，矯正方法為輸 FFP 或 PC，4 小時前輸血。
- PPN 為 SMOF Kabiven，流速一律為 60cc/hr，不建議調慢。
- TPN 需會診營養治療科，有任何問題可與營養師聯絡。
- 止吐藥除 Novamin 以外，皆為自費(健保給付特殊止吐藥會於化療藥囑開立)。

婦產科病房		**其他科檢查**		CXR Portable	GSM 60144
3KDR	8563-8564	X 光總台(CT)	2585 #316	電腦課	2048-2050
5K	8571-8572	急診 CT	2568	病歷室	3150-3154
6K	8586-8587	MRI	8400-8402		
9K	8613-8614	PET	3595-3597	轉介師	52866/2824
10K	8609-8610	DVT Dupplex	一科 2368 二科 2443	社工師	52878
11K	8605-8606	Bone scan	2620	出院準備	2823
13L	8767	PICC	2577#323	安寧共照	66143
婦產科檢查室		小腸攝影	2585#310	化療藥局	2915, 2768
2K GYN SONA	8262-8263	ST room	2210-2211	詢問藥師	2690
11 K 子宮鏡	8808	大腸鏡	2949	營養師	52936
尿動力學室	2296 8272	胃鏡	2225/ 2235	TPN	2704
膀胱檢查室	8435	無痛	2217	RT	61272
抹片室	2773	胃鏡(出血)	2217	高壓氧	2477-2478
		甲狀腺超	2427		
胸超	2287-2288	腹超	2227-2228	病理科	2724-2725
肺功能	2282-2283	腎超	2686		
2D 心超	一科 2359-2360 二科 2369/2337	Holter	2357		

<婦癌病人常見症狀處理方式>

MANAGEMENT OF COMMON SYMPTOMS

The SGO emphasizes providing comprehensive care to gynecologic oncology patients from the time of diagnosis to death.[4,54] Therefore, it is important to understand how to manage common symptoms that patients with advanced malignancies experience.[4]

Anorexia

- Address reversible causes (constipation, pain, medications, hypercalcemia, mucositis)
- Gastrokinetic agents (metoclopramide, domperidone)
- Low-dose corticosteroids (short term)
- Progesterone agents
- Cannabinoids (dronabinol and medical marijuana)
- Counsel patients and caregivers away from meeting nutrition goals to avoid suffering from forced feeding

Bone Metastasis

- External-beam radiation
- Opioids and analgesic nerve blocks for pain control
- Bisphosphonates (pamidronate, zoledronic acid)
- Denosumab (human monoclonal antibody to inhibit the receptor activator of nuclear factor-kappa B to diminish maturation of osteoclasts)
- Surgery or interventional radiology (to stabilize the skeleton by vertebroplasty)

Brain Metastasis

- Consult radiation oncology and neurosurgery
- Steroids (only if symptomatic, dexamethasone orally 4–8 mg/d up to 100 mg/d for severe symptoms)
  - If plan for radiation start 48 hours before treatment to prevent severe cerebral edema
- Whole-brain radiation (one to three lesions and widespread disease)
- Surgery (good prognosis) and/or stereotactic radiosurgery (multiple lesions, incompletely resected single lesion)[55]
- Antiepileptic drugs (only for patients with seizures)

Constipation

- Rule out bowel obstruction and fecal impaction
- Initiate bowel regimen immediately with opioid use
- Stool softeners (docusate sodium)
- Osmotic agents (magnesium hydroxide, lactulose, polyethylene glycol)
- Stimulants (senna, bisacodyl)
- Lubricants (glycerin suppositories)
- Enemas (mineral oil, soap suds)
- Opioid antagonist (methylnaltrexone)

Delirium

- Discontinue all high-risk medications, regularly reorient the patient, minimize stimulation, minimize use of restraints, encourage use of glasses/hearing aids
- Hyperactive delirium

Downloaded for Anonymous User (n/a) at Chang Gung Memorial Hospital from ClinicalKey.com by Elsevier on May 05, 2020.
For personal use only. No other uses without permission. Copyright ©2020. Elsevier Inc. All rights reserved.

- Haloperidol (0.5–2 mg orally [PO]/intravenous [IV]/intramuscular [IM]/subcutaneous [SC] every 2–12 hours as needed) or chlorpromazine (12.5–50 mg PO/IV/IM/SC/rectally every 4–6 hours as needed)
- Olanzapine or risperidone (patients intolerant of haloperidol)
- Lorazepam (for irreversible, hyperactive delirium)

- Hypoactive delirium
  - No pharmacologic interventions have been proven to be effective

Dyspnea

First Line:

- Relaxation or distraction techniques (music, guided imagery, cognitive behavioral therapy)
- Fan (facial cooling/air movement)
- Oxygen (even in patients without hypoxemia)
- Physiotherapy/chest wall percussion (helps mobilize secretions)

Second Line:

- Systemic opioids (opioid-naive morphine 2.5–5 mg PO every 4 hours; long-active opioid-increased baseline by 30% and adjust breakthrough)
- Benzodiazepine (lorazepam 0.5–1 mg PO every 4 hours as needed)
- Anticholinergics (glycopyrrolate 0.2–0.4 mg SC/sublingual/PO every 4– 8 hours)
- Interventions specific to etiology (Table 1)

Hemorrhage

- Volume resuscitation (blood transfusion case-by-case basis)
- Psychological support to patient and family
- Apply pressure
- Dark towels and suction
- Consider sedatives or narcotics (midazolam 2.5–5 mg IV or SQ every 10–15 minutes as needed)

Table 1
Management of dyspnea based on etiology

Disease Process	Possible Intervention
Pneumonia	Antibiotics, pulmonary toilet
Lymphangitic tumor	Diuretics, glucocorticoids
Pneumonitis, radiation or chemotherapy induced	Glucocorticoids
Venous thromboembolism	Anticoagulation, interior vena cava filter
Pleural effusion	Indwelling catheter, thoracentesis, video-assisted thoracoscopic surgery, pleurodesis
Airway obstruction by tumor or lymphadenopathy	Radiation therapy, glucocorticoids
Bronchoconstriction (chronic obstructive pulmonary disease, asthma)	Bronchodilators, glucocorticoids
Retained or excess secretions	Anticholinergic agents
Massive ascites	Drainage, including indwelling catheter
Anxiety, including hyperventilation	Anxiolytics, cognitive behavioral therapy

From Landrum LM, Blank S, Chen LM, et al. Comprehensive care in gynecologic oncology: the importance of palliative care. Gynecol Oncol 2015;137(2):194; with permission.

Downloaded for Anonymous User (n/a) at Chang Gung Memorial Hospital from ClinicalKey.com by Elsevier on May 05, 2020.
For personal use only. No other uses without permission. Copyright ©2020. Elsevier Inc. All rights reserved.

- Genitourinary
  - Packing (vaginal hemorrhage)
  - Bladder irrigation (bladder hemorrhage)
    - Cystoscopic coagulation > infusion of 1% alum
    - Administration of prostaglandin E_2 and silver nitrate
    - Formalin
  - External-beam radiotherapy (hypofractionation, 2 fractions over 2–3 days)
  - Arterial embolization by interventional radiology
- Gastrointestinal
  - Endoscopy
  - Surgical ligation or clipping of bleeding vessels

Hypercalcemia (Adjusted Total Serum Calcium >10.2)

- Hydration with intravenous normal saline
- Bisphosphonates (pamidronate or zoledronic acid)
  - Addition of calcitonin in patients with severe hypercalcemia

Intractable Symptoms at End of Life

- Palliative care consultation recommended
- Family meeting to verify goals of care/discuss sedation
- Midazolam, methotrimeprazine, propofol, phenobarbital

Malignant Ascites

- Maximize diuretics to decrease albumin loss
  - Furosemide (40–80 mg IV/PO twice a day) and spironolactone (50–200 mg PO twice a day)
- Paracentesis (immediate symptom relief)
- Permanent drains

Malignant Bowel Obstruction (Nonoperable)

- Conservative management with nasogastric tube
- Intravenous fluids
- Partial bowel obstruction
  - Prokinetic agent, metoclopramide
  - Steroid, dexamethasone
  - Antiemetic, haloperidol
  - Antispasmodic, hyoscine butylbromide
- Complete bowel obstruction
  - Avoid prokinetic agent if increased cramping/pain
  - Steroid, dexamethasone
  - Antiemetic, haloperidol
  - Octreotide to decrease secretions
  - Consider gastrostomy tube
  - Total parenteral nutrition (ONLY if possibility of surgery in the future)

Nausea/Vomiting

- Use optimal dosing/route (Table 2)
- Scheduled dosing
- Maximize primary agent and then add secondary (do not switch agents)
- Avoid drugs with similar toxicities (reduces side effects)

Pain Management

- Per the WHO analgesic ladder for pain management pain should be treated in a stepwise fashion first using nonopioids plus or minus adjunctive analgesics followed by opioid combinations including nonopioids and adjunctive analgesics (Table 3)[56]
- Long-active opioid and short-acting opioid for breakthrough pain if necessary
  - Dosage of long-acting opioid is based on 24-hour needs
  - Breakthrough is ~10% of 24-hour opioid dose
- Rotate opioid if unmanageable side effects
- Regularly monitor for opioid toxicity specifically in patients with renal dysfunction
- If pain decreased because of treatment, gradually decrease opioids to avoid oversedation
- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
- Neuraxial blocks

Downloaded for Anonymous User (n/a) at Chang Gung Memorial Hospital from ClinicalKey.com by Elsevier on May 05, 2020.
For personal use only. No other uses without permission. Copyright ©2020. Elsevier Inc. All rights reserved.

Table 2
Antiemetic agents, dosing, and adverse effects

Class	Drug	Principal Action	Route	Dose	Frequency	Major Adverse Events
Dopamine antagonist	Chlorpromazine	CTZ/vomiting center	PO/IM/IV	625 mg	Q 8 h	Dystonia, akathisia, sedation, postural hypotension
	Prochlorperazine	CTZ	PO PR IM/IV	50–10 mg 25 mg 10–20 mg	Q 4–6 h Q 3–6 h	Dystonia, akathisia, sedation
	Metoclopramide	CTZ/GI cholinergic	PO/IV	10–20 mg	Q 2–4 h	Dystonia, akathisia, esophageal spasm, colic
	Haloperidol	CTZ	PO/IV	0.5–1 mg	Q 8 h	Dystonia and akathisia, anticholinergic, sedation
Anticholinergic	Scopolamine	Vestibular, vomiting center	Transdermal	1.5 mg	Q 3 d	Dry mouth, blurred vision, ileus, urinary retention, confusion
	Hydroxyzine	Periphery, GI tract	PO	6.25–25 mg	QHS	Dry mouth, sedation, dystonia
H_1 antihistamine	Diphenhydramine	Vomiting center	PO IV/IM	50–75 mg 25–50 mg	Q 4–6 h	Sedation, dry mouth, urinary retention
	Promethazine	Upper GI tract, vomiting center	PO/IM	12.5–25 mg	Q 8 h	Dystonia, akathisia, sedation
5-HT3 antagonist	Ondansetron Dolasetron Granisetron Palonosetron	Upper GI tract, CNS	PO/IV/SL PO PO IV Transdermal IV	4–8 mg 100 mg 2 mg PO 0.01 mg/kg 3.1 mg 24 h 0.25 mg	Q 4–8 h Q 24 h Q 24 h 1 mg Q 24 h Q 7 d Q 24 h	Headache, fatigue, constipation
Steroids	Dexamethasone	Not known	PO/IV	4–24 mg	Q morning	Hyperglycemia, headache, oral candidiasis, peptic ulcer, insomnia, anxiety, psychosis
Cannabinoids	Dronabinol	Vomiting center	PO	7.5–15 mg	Q 3–4 h	Sedation, anticholinergic euphoria, dysphoria, tachycardia
Benzodiazepine	Lorazepam	Not known	IV, PO	0.5–2 mg	Q 4 h	Mild sedation, amnesia, confusion (avoid in elderly)

Abbreviations: CNS, central nervous system; CTZ, chemoreceptor trigger zone; GI, gastrointestinal; IM, intramuscular; IV, intravenous; PO, per os; PR, per rectum; SL, sublingual.

From Landrum LM, Blank S, Chen LM, et al. Comprehensive care in gynecologic oncology: the importance of palliative care. Gynecol Oncol 2015;137(2):196; with permission.

Downloaded for Anonymous User (n/a) at Chang Gung Memorial Hospital from ClinicalKey.com by Elsevier on May 05, 2020.
For personal use only. No other uses without permission. Copyright ©2020. Elsevier Inc. All rights reserved.

Table 3
Adjuvant pain medications

Class	Drug	Principal Action	Route	Starting Dose	Frequency	Major Adverse Events
Steroids	Dexamethasone	Inhibit prostaglandin synthesis	PO	1–2 mg	QD or BID	Hyperglycemia Headache Oral candidiasis
	Prednisone	Decrease inflammation	PO	7.5–10 mg	QD	Insomnia Anxiety Psychosis
Antidepressants	Desipramine	Tricyclic antidepressants, inhibit norepinephrine reuptake	PO	10–25 mg	QHS	Prolong QTc interval Sexual dysfunction Anticholinergic effects
	Nortriptyline		PO	10–25 mg (may increase to 50–150 mg QHS)	QHS	Lower seizure threshold
	Venlafaxine	Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor	PO	37.5 mg (may increase up to 37.5–112.5 mg BID)	QD	Nausea Sexual dysfunction Somnolence Hypertension
	Duloxetine		PO	30 mg (may increase up to 60 mg)	QD	
Anticonvulsants	Gabapentin	Inhibit depolanzation of neurons	PO	100–300 mg (may increase up to 900–3600 mg in BID-TID doses)	QHS	Dizziness Somnolence
	Pregabalin		PO	50 mg (may increase to 100 mg TID)	TID	Mental cloudiness
Bisphosphonates	Pamidronate Zoledronic acid	Osteoclast inhibitors	IV IV	60 mg 4 mg	Q month Q 21 d	Renal impairment Flulike syndrome with initiation of treatment

From Landrum LM, Blank S, Chen LM, et al. Comprehensive care in gynecologic oncology: the importance of palliative care. Gynecol Oncol 2015;137(2):199; with permission.

<婦女泌尿科>

1.作泌尿道手術後的病人，Remove Foley 後需要 check RU(residual urine)五次。

- Order: check RU 5 times by scan, if RU>100 or 150ml→> ICP
- check RU 時間: 9, 12, 15, 18, 21

2.解尿不順的病人：**(每個 MA 習慣不同, 要開藥都要先問過主治醫師!!!)**

- Cholinergic Agonist: Bethanechol 1pc TID
- Selective alpha-1 blocker: Silodosin(Urief) or Tamsulosin
- Antispasmodic: Propiverine(Urotrol) 1pc BID
- Erispan(Fludiazepan) 1pc TID
- Imipramine 1pc BID

3.解尿疼痛感：

- Pyridium(Phenazopyridine HCl 100mg/tab) 1pc TID

0187 梁景忠醫師

*尿不好，可以先給 Bethanechol 1pc tid(注意口乾、暈眩副作用)

**記得，開藥需多開 once 劑量，趕緊讓病患吃到藥，不要拖時間有

***** 開 PRP(Platelet-rich plasma)的病人術後止痛不使用 NSAID******

Pre-op order: **他科範本 → 4720 產科範本 → B04(陰道) or B05(腹腔鏡) → Admission order**

= Op will be performed on (日期)

= OP method (同手術同意書一字不差, 記得加最上面的標題**(婦產科)**

= Op site (同手術同意書一字不差)

= Sign consent form (同手術同意書一字不差, 記得加最上面的標題**(婦產科)**

= Sign 自費特材同意書 (尿失禁 Sling or 脫垂 Mesh or 腹腔鏡 Mesh or 防沾粘 or New Epi)

= 術中決定防沾粘 (看病人意願, 腹腔鏡才要)

= Sent patient to OR on call with chart

= On Foley at OR

= Skin preparation at OR

= NPO since midnight (有血壓藥或術前藥記得 except drug)

= IVF: D0.225S or NS run 60/80/100/125ml/hr since cm (看病人年齡體重&是否有高血壓糖尿病微調)

D0.225S 1000ml + RI 6u run 80ml/hr since cm (若病人嚴重的糖尿病)

= 備血/輸血

Pre-op 藥物

- Fleet enema 1pc cm 大部分都要, 有些只做尿失禁的不用
- Cefazolin 1g IV to OR (Cefalosporin 過敏: Clindamycin 600-900mg IVF to OR) 全都要!
- 止痛藥 Dynastat 1pc IV before to OR 自費 腹腔鏡, 脫垂手術比較需要, 尿失禁不太需要
- 止吐藥 Kytril 1pc IV to OR 自費 腹腔鏡需要
- 如果要拿子宮記得開 Pyridium 1pc IRRE PO, 1pc HS + 1pc CM 首日量 2 每日量 0

自費特材 本院材編可參考後面附錄

- 尿失禁手術：健保 Kim, Obytrix 不用開; 自費 I-stop-min, Ophira, Solyx, AITIS
- 陰道脫垂手術：自費 Surelift, Calistar-S , Uphold
- 腹腔鏡薦骨陰道固定術：健保 Hernia Mesh, 自費 HalbaMesh, DynaMesh, Upsylon, Pelvi-STOP
- Cystoscopy PRP injection 20mL 68-906-BJS02E
- New Epi 速原水性創傷敷料：促進組織再生及修復

<生殖內分泌暨不孕症科>

1. Ovarian hyperstimulation Syndrome(OHSS) 病人: Monitoring:

- Record I/O q8h ; Record AC(腹圍) and BW QD
- LAB: CBC(or only Hb, Hct), Electrolytes, BUN, Creatinine, liver enzyme, serum hCG(Pregnant status)
- IV Hydration: N/S run 80-100ml/hr
- Pain control: Acetaminophen. **避免 NSAIDS or antiplatelet drugs**
- Arrange abdominal sonography (For check ov size and ascites, by MA order)
- Medication:請詢問病人門診有用那些口服藥，任何藥物都要跟主治醫師確認後再開立
  - ✓ **DC 剩餘之 HCG。**
  - ✓ Hydroxyprogesterone caproate 1amp qod * 3 times(若 DC HCG 時)
  - ✓ Cabergoline 1pc qd (詢問 MA 後再開立)
  - ✓ **If oligouria, avoid diuretic use**
  - ✓ **If massive ascites, avoid tapping**

危險信號 RED FLAGS

- 1.Third-space fluid accumulation (Ascites, Pleural effusion, Pericardial effusion)
- 2.Thromboembolic events

附錄：婦產科全民健康保險自費特材同意書

***2023 開始腹腔鏡 Suction irrigation 納入健保不用再開立!

<開立路徑>：

住院醫囑→病歷記載→同意書→同意書開立→查詢所有科別→管理部→自費特材及自付差額特材→範本→科用自費特材→林口婦女內視鏡科→依需求(LOVA/LM/LAVH/LSH/TCR 冷刀/防沾粘)點選耗材→按確認→存檔→簽名同意書

***建議都先依手術方式選顏醫師的範本，再增減特材（主要是 Ligasure 或 防粘粘的部分要更動）**

**如果門診病歷 or 住院通知單 or 手術排成有備註下面沒有的特材, 也可以直接打英文 or 中文搜尋

<特別開立路徑>：TISSEEL, 3D 腹腔鏡

住院醫囑→病歷記載→同意書→同意書開立→查詢所有科別→管理部→(拉到最下面)病患自費切結

收費編號:3D 腹腔鏡(91-001); TISSEEL(PZA292E)+ 噴管(84-120-600030)或塗管(84-120-SA3760)2 擇 1 ; HIPEC(49-471); 自費 CS (S50-020); 自留臍帶血(S49-310); ATS(58-065: CS 者 NT3162;)

腹腔鏡基本器械 腹腔鏡卵巢切除手術(LOVA)、腹腔鏡子宮外孕手術(LECT)		
收費編號	中文名稱	英文名稱
84-999-113031	ENDOSCOPIC GRASP(藍)	ENDOSCOPIC GRASP
84-984-008312	拋棄式牽引器(XS)	WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS XS
84-550-000012	內視鏡專用檢體袋(大) 擇一	ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8"
84-550-000011	內視鏡專用檢體袋(小)	ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 3" X 6"

腹腔鏡子宮肌瘤切除手術(LMYO)、腹腔鏡次全子宮切除手術(LSATH)			
	收費編號	中文名稱	英文名稱
	84-999-113031	ENDOSCOPIC GRASP(藍)	ENDOSCOPIC GRASP
二擇一	84-984-008301	拋棄式牽引器(S) for **NOTES**	WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS S
	84-984-008312	拋棄式牽引器(XS) **一般腹腔鏡! 大多選這個!**	WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS XS
三擇一	84-VAL-LF1837	利嘉修爾鈍頭含塗層閉合分離器 **不知道開什麼就先開這個**	LIGASURE BLUNT TIP OPEN SEALER/DIVDER 5MM X 37CM AS:COVIDIEN LF1837
	84-VAL-LF1737	利嘉修爾馬里蘭	LIGASURE MARYLAND **黃寬仁醫師愛用**
	84-310-HARH36 84-ETH-0HP053 **選這項兩個都要開**	(腹腔鏡) 超音波諧波刀儀儀止血切割彎剪 + 銀線	Harmonic **張廷璋醫師**

	84-302-CL0316	可吸收傷口縫合裝置 V-Loc **可以直接開 3 條**	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM
	84-550-000012	內視鏡專用檢體袋(大)	ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8"

腹腔鏡全子宮切除手術(LAVH)			
	收費編號	中文名稱	英文名稱
	84-999-113031	ENDOSCOPIC GRASP(藍)	ENDOSCOPIC GRASP
二擇一	84-984-008301	拋棄式牽引器(S) for NOTES	WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS S
二擇一	84-984-008312	拋棄式牽引器(XS) **一般腹腔鏡! 大多選這個!**	WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS XS
四擇一	84-VAL-LF1837	利嘉修爾鈍頭含塗層閉合分離器 **不知道開什麼就先開這個**	LIGASURE BLUNT TIP OPEN SEALER/DIVDER 5MM X 37CM AS:COVIDIEN LF1837
四擇一	84-VAL-LF1737	利嘉修爾馬里蘭	LIGASURE MARYLAND **黃寬仁醫師**
四擇一	84-310-HARH36 84-ETH-0HP053 **選這項兩個都要開**	(腹腔鏡) 超音波諧波刀儀儀止血切割彎剪 + 銀線	Harmonic **張廷璋醫師**
四擇一	84-GYR-3005PK	PK 雙擊脈衝氣化電凝器	PK knife 刀 **李奇龍醫師**
	84-302-CL0316	可吸收傷口縫合裝置 V-Loc **開 1 條**	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM
	84-550-000012	內視鏡專用檢體袋(大)	ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8"

開腹癌症手術(Lapa)		
收費編號	中文名稱	英文名稱
84-310-HAR17F	(開腹)超音波諧波刀儀止血切割彎剪	HARMONIC
84-996-022002	(開腹)組織凝集儀手控加長型電極	LIGASURE MAX
84-999-113010	自動手術縫合釘	Autosuture

HIPEC		
收費編號	中文名稱	英文名稱
84-041-900088	保福腹腔溫熱灌注套管組	

防沾黏 **防沾黏材料 Tisseel(參考上方<特別開立路徑>)要記得簽噴管或塗管 2 擇 1** 若病人同意使用防沾黏可先於 order 開立”術中決定防沾黏”		
收費編號	中文名稱	英文名稱
84-120-600030	**<特別開立路徑>**	Duplospray 40cm (Tissel 噴管)
84-120-SA3760	**<特別開立路徑>**	Duplo tip dual lumen cannula 32cm (Tissel 塗)
84-286-501573	克沾黏溶液	ADEPT 1500CC BAXTER
84-286-076200	亞諾貝爾生化可吸收膠	HYALOBARRIER GEL ENDO
84-286-076204	防沾黏可吸收膠	BARRIGEL 40MG/ML 10ML/PC
84-286-076205		BARRIGEL 40MG/ML 5ML/PC
84-286-000006	玻達癒可吸收防沾黏凝膠 6ML	PROTAHERE ADHESION BARRIER 6ML/PC
84-120-934057	伏血凝止血劑	FLOSEAL
84-120-934073		Coseal (2ml)
84-120-934071		Coseal (4ml)
84-286-430506	防粘黏薄膜	SEPRAFILM ADHESION BARRIER 5"X 6"
84-286076102		Interceed
84-286-076206	宮安康	Materegen gel 5ml
84-286-SM0002 or 5 or 7	亞瑞斯達可吸收止血顆粒	Arista 1gm/3gm/5gm

傷口敷料	
收費編號	中文名稱
84-152-005005	(5*5 cm)赫麗敷水凝膠傷口敷料 (scope) 周宏學醫師
84-996-495400	美皮蕾防水矽膠敷料 $550
84-094-604300	Mepiform 美皮豐美容疤痕矽膠布 $1605
84-094-WDS002	Wellderm 矽膠疤痕貼片 4pc /組 $720
68-007-015012	倍舒痕疤痕凝膠 15gm $1980
68-007-015020	芙立康疤痕凝膠 20ml $2080
68-007-005541	玻麗舒疤痕凝膠 15gm $1850
68-007-009302	優潔疤痕護理凝膠 20gm $2800

婦女泌尿科尿道吊帶及陰道補片手術 (請參考門診紀錄/手術排程備註/住院通知單備註之項目)			
收費編號	中文名稱	英文名稱	價格
MidUrethral Sling 尿道中段懸吊術 for SUI 尿失禁			
84-301-507000	鎖淋 單一切口吊帶系統	Solyx SIS System	$29900
84-301-ISM100	愛適達 迷你懸吊手術系統	I-stop (Mini-Stop) Sling System	$33000
84-301-519650	單一切口吊帶系統	Single Incision Sling System AS:ALTIS	$34500
84-301-KIT001		Ophira	$29000
Transvaginal Mesh 陰道補片手術 for Prolapse 脫垂			
84-301-CPS020	舒兒莉芙特骨盆懸吊系統	Surelift Contasure Prolapse System	$35880
84-301-00000A	凱莉星脫垂修補系統前壁	Calistar POP Repair System Anterior	$34800
84-301-00000P	凱莉星脫垂修補系統後壁	Calistar POP Repair System Posterior	$30000
84-301-S00000	凱莉星脫垂修補系統	Calistar POP Repair System AS: Calistar S	$45625
84-301-318170	歐普候陰道支撐系統	Uphold LITE	$55000
Laparoscopic Sacrocolpopexy Mesh 腹腔鏡薦骨陰道固定術 for Prolapse 脫垂			
84-301-000316	狄伯密尿失禁子宮陰道懸吊	3x16cm AS:DIPROMED [HAlbaMeSH]	$28750
84-286-350323	女性骨盆底修復網膜片	Mesh For Female Pelvic Floor Surgery:DynaMesh	$36000
84-286-831822	歐普隆網片套組	Upsylon Y Mesh and Colpassist	$55600
84-286-PSTOP8	倍樂適特骨盆底修復網片	AS:APIS P-STOP-8 [Pelvi-STOP]	$54600

77R 婦產科專科材料 (自費)

品名	材料編號	金額
計86房		36000
Harmonic(LAPA)(5)	84-ETH-0CS14C	~~7400~~元
Harmonic(LAPA藍線)(100)(X自費)	84-ETH-HPBLUE	2000元
Harmonic(SCOPE)(5)	84-ETH-ACE36E	7400元
Harmonic(SCOPE銀線)(200)	84-ETH-0HP053	~~1850~~元
Ligasure(Lapa)	84-996-022002	5600元
驗孕劑	S49-066	160元
Auto Suture (原裝)	84-999-113010	410元
計88房		
16G取卵針 計88R	84-266-PS1635	3600元
17G取卵針 計88R	84-266-PS1735	2800元
計93房		18500
PK刀 (4)	84-GYR-3005PK	~~7000~~元
Ligasure 5mm(2)	84-VAL-001100 23500	~~14000~~元
Ligasure小海豚(10)	84-VAL-004200 25700	~~4200~~元
2-0 V-LOC	84-302-CL0315	2300元
3-0 V-LOC	84-302-CL0614	2300元
赫麗敷(5*5cm)	84-152-005005	135元
赫麗敷(7*10cm)	84-152-007010	465元
赫麗敷(6*19.5cm)	84-152-006195	563元
Patent Blue	PHB002P	1800元
庫台4Y000		
TISSEEL(2c.c.)	PZA292E	15000元
TISSEEL(4c.c.)	PZA293E	25000元
多善來防水盲孔用導管	80-120-SA3760	2020元
子宮鏡材料(各房間均可計價)		
TCR irrigation tube	84-OHI-200903	180元
子宮內氣球托	84-972-253000	2000元
子宮鏡切除器來回擺動刀片	84-972-210908	39000元
子宮鏡切除器用旋轉刀片	84-972-209509	39000元
防沾黏類(各房間均可計價)		
Coseal(2ml)	84-120-934073	20000元
Coseal(4ml)	84-120-934071	29000元
Barri gel (5ml)	84-286-076205	8500元
Barri gel (5ml) 10 ml	84-286-076204	15000元
亞諾貝爾生化凝膠	84-286-076200	14200元
克沾黏溶液Adept	84-286-501573	14000元
Seprafilm	84-286-430506	12700元
Interceed	84-286-076102	5300元
Floseal	84-120-934057	15000元

品名	材料編號	金額
腹腔鏡材料(各房間均可計價)		
Grasp	84-999-113031	2900元
Laser套	84-999-011003	80元
Suction Irrigation(短)	84-OHI-200902	800元
Suction Irrigation(長)	84-041-200020	1900元
W'd retractor (S)	84-984-008301	3200元
W'd retractor (XS)	84-984-008312	2800元
W'd retractor (60mm)	84-984-0060ES	1900元
GIA 30-2.5 Stapler (白釘+槍)	84-999-113025	5500元
GIA 30-3.5 Stapler (藍釘+槍)	84-999-113026	5500元
GIA 30-2.5 Unit (白釘)	84-999-113027	2900元
GIA 30-3.5 Unit (藍釘)	84-999-113028	2900元
Endo Loop	84-ETH-0E210G	1050元
Endo Close	84-310-173022	2300元
Endo Bag 3"*6"	84-550-000011	1150元
Endo Bag 5"*8"	84-550-000012	1400元
Endo stitch polysorb 1-0	84-310-170052	2100元
Endo stitch polysorb 3-0	84-310-170071	2100元
Lagi-port(腹部)	84-310-050220	25000元
Lagi-port(會陰部)	84-310-050800	25000元
Glove Port	84-984-0440AM	29000元
Glove Port (NOTES)	84-984-0431AM	29000元
泌尿科材料(各房間均可計價)		
Solyx	84-301-507000	29900元
Uphold LITE	84-301-318170	55000元
Avaulta(A)	84-301-010061	32000元
Avaulta(P)	84-301-010062	32000元
Adjust Sling	84-301-010070	30000元
COOK mesh 8*13cm	84-286-208013	29000元
COOK SLING KIT	84-301-010052	44000元
縫線類(各房間均可計價)		
1-0 V-LOC	84-302-CL0316	~~2300~~元 1600
Stratafix2-0雙頭14*14cm	84-302-D2B414	1500元
Stratafix1-0雙頭24*24cm	84-302-D2B402	1500元
Stratafix2-0單頭30cm	84-302-D1B401	1500元
HIPEC(各房間均可計價)		
保福腹腔溫熱灌注套管組	84-041-900088	95000元

Harmonic L's 84-310-HARH36 27000元 Lapa 84-310-HARH7F 24000元

Ligasure Maryland 84-VAL-LFH37 28000元

Tmclear
藍 84-P22-20P15OS
黑 84-
(自費 3P000元)